



**ЮСУПОВСКАЯ
БОЛЬНИЦА**

Российские традиции
Европейские технологии

ООО «Нейро-клиника»
117186, г. Москва, ул. Нагорная, дом 17, корпус 6
Тел.: +7(495) 585-55-50
ОГРН 1137746528644
ИНН/КПП 7701362594 / 772701001
www.yusupovs.com
info@yusupovs.com
117186, г. Москва, Нагорная ул., д. 17, корп. 6
тел.: 8(499) 750 00 04
лицензия № ЛО-77-01-019798 от 19.03.2020г.

Пациент: **МИКОВА Чiana Сергеевна**
Дата рождения: **24.01.1977** Возраст: **48** лет
Медицинская карта №: Пол: **женский**
Дата: **17.12.2025 19:01**

Консультация невролога - специалиста по когнитивным нарушениям

Жалобы: на ощущение «засвеченности букв», эпизоды дезориентации, эпизоды амнезии при выраженной усталости;

История заболевания: С анамнезом заболевания ознакомлена со слов пациентки и по данным предоставленной медицинской документации. В январе 2025 г. отравление в ресторане ОАЭ с потерей сознания, комой, желудочным кровотечением. В ан. крови - лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг, повышение меди. Не может работать. 08.12.25 консультирована неврологом Косовой Т.А.: Постгипоксическая и токсическая энцефалопатия. Синдром легких нейрокогнитивных нарушений. Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы. Анализы крови на ЦЖ от 14.12.25: ТТГ 0,679 мкМЕд/мл, Т4 св. – норма. АТ к ТПО – норма. Танакан – эффект в течение 3х часов. Пирацетам – без эффекта.

ОАК: в норме. **БАК:** снижение вит. Д до 20, гиперлипидемия, повышение ртути в волосах.

ЭЭГ: дезорганизация основного ритма альф-ритм и повышение медленно волновой активности без эпилептиформных паттернов.

МРТ ГМ: микроангиопатия.

ЭКГ от 26.11.25: Синусовая брадикардия. Вертикальное положение ЭОС.

Аллергологический анамнез: неотягощен.

Сопутствующие и перенесенные заболевания: Хр. заболевания отрицает. Эрозивный гастрит по ЭГДС. Кисты почек. Кисты печени. Маммопластика, блефаропластика. Гипергомоцистеинемия.

Принимаемые препараты на момент осмотра: оmez, ребагит.

Образование высшее техническое, работала программистом, финансовым консультантом.

Общий осмотр: Правша. Пациентка в ясном сознании, контактна, правильно ориентирована в месте, времени и собственной личности. Критика к своему состоянию сохранена. Темп познавательной деятельности снижен. Колебания концентрации внимания. Эмоционально лабильна. Социальный интеллект не нарушен.

Память: нет нарушений.

Тест на запоминание и воспроизведение 12 слов: непосредственное воспроизведение 9+3=12 слов, отсроченное воспроизведение 9+3=12 слов. 0 посторонних вpletений.

Праксис: нет нарушений.

Гнозис: нет нарушений.

Речь: Обращенную речь понимает полностью. Собственная речь грамматически правильная, развернутая, плавная. Беглость речи снижена. Понимание логико-грамматических конструкций сохранено. Литеральных и вербальных парафазий нет. Номинативная функция речи не нарушена. Литеральные ассоциации: 10 слов. Категориальные ассоциации: 19 слов.

Управляющие функции: инертность познавательной деятельности.

БТЛД (ФАВ) = 16 б. Тест рисования часов: 10 б.

ТМТ часть А = 36 сек. ТМТ часть В = 113 сек.

Тест символично-цифрового кодирования (90 сек): 30 правильных ответов, 0 ошибок.

В неврологическом статусе: Общемозговых и менингеальных симптомов нет. ЧМН: Поля

зрения сохранены. Глазные щели равны. Зрачки равные, фотореакции живые. Глазодвигательных нарушений нет. Нистагма, диплопии нет. Физиологическая асимметрия лица. Слух не изменен. Глотание, фонация в норме. Язык по средней линии. В двигательной сфере: амплитуда движений в конечностях полная, сила 5 баллов. Мышечный тонус не изменен, S=D. СХР торпидны, S=D. Патологических знаков нет. ПНП, ПКП выполняет удовлетворительно. Постуральный мелкоамплитудный тремор кистей. В пробе Ромберга устойчива. Чувствительных нарушений нет. Функции тазовых органов не нарушены.

Диагноз заключительный клинический:

Основное заболевание: G93.8 Постгипоксическая и токсическая энцефалопатия. Астенический синдром. Синдром легко-умеренных нейрокогнитивных нарушений дизрегуляторного и нейродинамического характера. Гипергомоцистеинемия.

Назначения и рекомендации:

1. Анвифен 50 мг 1 капс x 3 раза в день после еды, при недостаточном эффекте повысить до 250 мг 1 капс x 2-3 раза в день 1 месяц;
2. Отзвониться через колл-центр через 2 недели на фоне приёма анвифена, при недостаточном эффекте добавить Бринтелликс по схеме: 10 мг 1-8 день 1/4т утром, 9-16 день 1/2 т утром, с 17 дня 1т утром не менее 12 месяцев, решение вопроса о продолжении терапии в динамике (клинический эффект развивается через 3-4 недели от начала приёма, возможный побочный эффект - тошнота);
3. Ангиовит 1т утром независимо от приёма пищи 2 месяца;
4. Консультация психиатра Гладышева В.Н./Смирновой В.Н. при неэффективности терапии;
5. Повторная консультация через 1 месяц.

Врач: Громова Д.О.

